

Escopo de Entrega MVP Funcional

e sugestão de fases futuras

CLÍNICA DR. GUILHERME

Versão revisada • 04 de setembro de 2026

Diretriz central

O protótipo valida a experiência e o fluxo do produto. O MVP transforma essa experiência em um produto funcional, com praticamente todas as funcionalidades aprovadas no protótipo operando de ponta a ponta.

O MVP deverá estar apto a um piloto controlado com dados persistentes, acesso seguro, rastreabilidade, supervisão médica e suporte operacional.

1. Decisão de escopo

A entrega não será apenas uma interface demonstrativa. A regra de escopo é simples: tudo o que for validado no protótipo como parte da jornada principal deverá ser implementado de forma funcional no MVP, salvo exceções técnicas, regulatórias ou clínicas registradas neste documento.

Etapa	Objetivo	Resultado esperado
Protótipo	Validar proposta de valor, experiência, telas, linguagem, fluxos e prioridades.	Produto navegável para decisões, com dados fictícios e sem compromisso de operação real.
MVP funcional	Transformar o fluxo aprovado em produto utilizável por médico, equipe e pacientes em ambiente controlado.	Jornadas completas, dados persistentes, segurança, auditoria, IA supervisionada e operação de piloto.
Fases futuras	Expandir integrações, aquisição, automação avançada, inteligência e escala.	Capacidades adicionais que aumentam alcance e eficiência, sem completar lacunas essenciais do MVP.

1.1 Regra para passagem do protótipo ao MVP

- **Fluxo aprovado entra no MVP:** telas, ações, estados, regras e mensagens necessários para concluir a tarefa real.
- **Não basta reproduzir a tela:** os dados precisam ser gravados, recuperados, protegidos e auditáveis.
- **Exceção explícita:** somente itens de alto risco, dependentes de certificação ou claramente voltados a escala podem usar alternativa segura no MVP ou seguir para fase futura.
- **Controle de escopo:** uma funcionalidade aprovada no protótipo só sai do MVP mediante decisão registrada; uma funcionalidade nova segue avaliação de impacto, prazo e custo.

1.2 Resultado esperado do MVP

Produto funcional para uso controlado

Ao final do MVP, médico, equipe e pacientes selecionados deverão conseguir executar a jornada longitudinal principal, do preparo da consulta ao acompanhamento, sem depender de dados fictícios ou de operações invisíveis apenas para demonstração.

2. O que será entregue no MVP funcional

O MVP reúne a experiência validada no protótipo e a base técnica mínima necessária para que essa experiência funcione de verdade.

2.1 Base funcional, segurança e operação

Capacidade	Entrega funcional
Acesso e perfis	Autenticação, recuperação de acesso e permissões por papel para médico, equipe e paciente.
Dados persistentes	Banco de dados com identidade única do paciente, histórico e continuidade entre sessões.
Privacidade e LGPD	Consentimentos, minimização de dados, controle de acesso, política de retenção e registro das bases aplicáveis.
Rastreabilidade	Registro de autor, data, alteração, aprovação, publicação e acesso às informações clínicas relevantes.
Arquivos	Envio, armazenamento, visualização e recuperação segura de exames, relatórios, fotos e documentos.
Confiabilidade	Backups, logs, monitoramento, tratamento de falhas e canal de suporte compatíveis com o piloto.

2.2 Jornada do médico e da equipe

- **Painel do dia:** agenda, pacientes que exigem atenção, pendências e próximos passos.
- **Agenda e acompanhamento:** consultas, retornos, tarefas, responsáveis, prazos e lembretes.
- **Prontuário longitudinal:** perfil, linha do tempo, histórico, documentos, exames, mensagens e evolução.
- **Pré-consulta:** revisão estruturada das informações enviadas pelo paciente e preparação da consulta.
- **Consulta e registro:** espaço de trabalho para notas estruturadas, decisões e definição dos próximos passos.
- **Plano de cuidado:** criação assistida, revisão médica, aprovação, publicação ao paciente e versionamento.
- **Relatórios e evidências:** visão de adesão, evolução, check-ins, exames e informações necessárias à decisão clínica.

2.3 Jornada do paciente

Área	Entrega funcional
Hoje	Visão simples das ações prioritárias, lembretes, pendências e próximo contato.
Meu cuidado	Plano vigente, orientações publicadas, metas, tarefas, retornos e materiais de apoio.
Pré-consulta	Questionários, sintomas, histórico, anexos e contexto enviados antes do atendimento.
Check-ins	Registro periódico de evolução, sintomas, adesão, medidas e observações definidas pela equipe.
Conversas	Mensagens seguras com histórico, contexto do paciente e regras de atendimento.
Evolução	Linha do tempo com dados permitidos, marcos, documentos e acompanhamento longitudinal.
Exames e registros	Envio de exames, relatórios, fotos e outros documentos solicitados.
Consultas e retornos	Visualização de compromissos, instruções e acesso ao atendimento pelo canal definido.

2.4 Continuidade do cuidado

Cada acompanhamento relevante deverá deixar claro o estado atual, a última ação, a próxima ação, o responsável, o prazo e a evidência associada. Essa lógica conecta consulta, plano, mensagens, check-ins e retornos.

- Fila de atenção baseada em pendências e sinais definidos pela equipe, sem diagnóstico autônomo.
- Cadência de acompanhamento com tarefas, notificações e lembretes no produto.
- Histórico íntegro das ações realizadas e das decisões aprovadas pelo médico.

3. Inteligência artificial dentro do MVP

A IA será funcional no MVP como apoio à organização, síntese e elaboração de rascunhos. Ela não substitui avaliação, decisão ou responsabilidade médica.

Uso da IA	O que o MVP entrega	Regra obrigatória
Síntese clínica	Resumo estruturado de questionários, histórico, check-ins, mensagens e documentos disponíveis.	Exibir origem e permitir conferência do conteúdo original.
Rascunhos	Sugestões de plano, orientação, mensagem, tarefa ou registro para edição do profissional.	Nenhum conteúdo clínico é publicado sem revisão e aprovação médica.
Organização	Classificação assistida de informações, pendências e contexto para preparar o atendimento.	A equipe pode corrigir, rejeitar ou refazer; decisões ficam rastreáveis.
Sinais de atenção	Destaque de respostas ou eventos conforme critérios previamente definidos.	Não realiza diagnóstico, prescrição ou decisão autônoma de urgência.

3.1 Fluxo clínico obrigatório

1. **Coleta:** paciente ou equipe registra a informação e o original é preservado.
2. **Apoio da IA:** o sistema produz síntese, organização ou rascunho identificado como assistido.
3. **Revisão profissional:** médico ou profissional autorizado confere, corrige, aprova ou rejeita.
4. **Publicação:** somente a versão aprovada fica disponível ao paciente.
5. **Acompanhamento:** check-ins, mensagens e retornos atualizam o histórico e os próximos passos.

3.2 Limites clínicos permanentes

- Sem diagnóstico autônomo, prescrição autônoma ou substituição da avaliação médica.
- Sem promessa de resposta imediata ou de atendimento de urgência pelo aplicativo.
- Alertas e recomendações de segurança devem orientar o paciente para os canais adequados definidos pela clínica.

4. Matriz do protótipo para o MVP

A matriz abaixo consolida os blocos principais. O detalhamento final seguirá as funcionalidades e estados aprovados no protótipo.

Bloco validado	Situação no MVP	Critério mínimo de funcionamento
Painel médico e fila de atenção	Incluído	Dados reais do piloto, filtros, pendências, responsáveis e acesso ao paciente.
Agenda e retornos	Incluído	Criar, alterar, consultar e acompanhar compromissos e lembretes.
Cadastro e prontuário longitudinal	Incluído	Identidade única, histórico persistente, documentos, eventos e permissões.
Pré-consulta	Incluído	Paciente envia; equipe revisa; médico acessa antes da consulta.
Consulta e registro	Incluído	Registro estruturado, salvamento, histórico e próximos passos.
Plano de cuidado	Incluído	Rascunho, revisão, aprovação, publicação e versões anteriores.
Hoje / Meu cuidado	Incluído	Paciente visualiza ações, plano vigente, pendências e orientações aprovadas.
Check-ins e evolução	Incluído	Cadastro, consulta, histórico e revisão pela equipe.
Conversas	Incluído	Mensagens no produto, histórico e vínculo com o contexto do paciente.
Exames, fotos e documentos	Incluído	Upload, armazenamento seguro, visualização e rastreabilidade.
IA assistiva	Incluído	Uso real do provedor escolhido, supervisão humana, fontes preservadas e logs.
Relatórios essenciais	Incluído	Informações operacionais e clínicas necessárias ao piloto e ao acompanhamento.

Regra de completude

Se um bloco constar no protótipo aprovado e for necessário para concluir a jornada principal, ele integra o MVP com comportamento funcional. A lista acima não reduz funcionalidades mais detalhadas já validadas.

5. Ondas internas de entrega do MVP

As ondas abaixo organizam a execução. Todas pertencem ao mesmo MVP; não são fases futuras nem itens opcionais.

Onda 1 — Fundação funcional

- Arquitetura do produto, ambientes, autenticação, papéis e permissões.
- Banco de dados, identidade do paciente, arquivos, auditoria, consentimentos e backups.
- Critérios clínicos, privacidade, segurança e regras de publicação aprovados para o piloto.

Onda 2 — Jornada completa médico/paciente

- Painel, agenda, cadastro, prontuário, pré-consulta, consulta e plano de cuidado.
- Hoje, Meu cuidado, Conversas, Evolução, check-ins, exames e documentos.
- Estados, mensagens, permissões e persistência equivalentes ao protótipo validado.

Onda 3 — Continuidade e IA supervisionada

- Próxima ação, responsável, prazo, tarefas, lembretes e fila de atenção.
- Sínteses e rascunhos reais com preservação das fontes, edição, aprovação e logs.
- Relatórios essenciais e visão longitudinal para acompanhamento do piloto.

Onda 4 — Estabilização e aceite

- Testes funcionais, segurança, privacidade, responsividade, acessibilidade e recuperação de falhas.
- Treinamento, suporte, monitoramento, correções do piloto e documentação operacional.
- Aceite formal após validação das jornadas críticas e dos critérios definidos neste documento.

5.1 Critérios de aceite do MVP

Dimensão	Condição de aceite
Jornada ponta a ponta	Médico e paciente concluem os cenários críticos sem dados fictícios ou intervenção técnica fora do fluxo.
Persistência	Cadastros, planos, check-ins, mensagens, documentos e histórico permanecem disponíveis entre sessões.
Segurança	Cada perfil acessa somente o que lhe é permitido; ações relevantes ficam registradas.
Supervisão clínica	Conteúdo assistido por IA é identificado e não chega ao paciente sem aprovação profissional.
Continuidade	O sistema mantém estado, próxima ação, responsável, prazo e evidências do acompanhamento.
Operação	Backups, monitoramento, suporte e procedimento de contingência estão disponíveis para o piloto.
Qualidade	Fluxos validados em desktop e celular, sem bloqueios críticos, com requisitos essenciais de acessibilidade.
Governança	Piloto autorizado após aprovação clínica, jurídica/LGPD, segurança e aceite dos responsáveis.

6. Exceções e alternativas seguras no MVP

Poucos itens podem aparecer no protótipo com uma experiência mais ampla do que a primeira implementação. Nesses casos, o MVP preserva a tarefa do usuário por uma solução segura e operacional.

Tema	Como funciona no MVP	Evolução posterior
Teleconsulta	Agendamento e acesso por link seguro ao serviço definido pela clínica.	Vídeo nativo, sala integrada, gravação autorizada e transcrição em tempo real.
Prescrição eletrônica	Registro e acesso ao documento ou ligação com serviço externo certificado, quando contratado.	Integração certificada e fluxo nativo, conforme requisitos legais e fornecedor escolhido.
Fotos de refeições	Envio, histórico e revisão pela equipe; apoio descritivo apenas se clinicamente aprovado.	Estimativas avançadas por visão computacional após validação clínica específica.
Canais externos	Mensagens e notificações essenciais dentro do produto; comunicação externa conforme canal operacional definido.	Integrações omnichannel completas com WhatsApp, e-mail, SMS e outros canais.

6.1 Itens que não fazem parte do MVP

- Diagnóstico, prescrição, triagem de urgência ou publicação clínica totalmente autônomos.
- Integrações com wearables e ecossistemas como HealthKit e Health Connect.
- CRM completo de captação, qualificação de leads, funil comercial, orçamentos, cobrança e pagamentos.
- Automação avançada de marketing, campanhas, mídia paga e integrações extensas com redes sociais.
- BI avançado, modelos preditivos, operação multiunidade e recursos específicos de grande escala.
- Recursos novos que não estejam no protótipo aprovado nem sejam necessários para a jornada principal.

Importante

As exceções não autorizam retirar do MVP uma jornada principal. Quando uma integração avançada ficar para depois, a tarefa correspondente deverá continuar executável por uma alternativa segura no produto ou no procedimento operacional acordado.

7. Sugestão de fases futuras

As fases futuras começam após o MVP funcional e seu aceite. Elas ampliam alcance, eficiência e escala; não substituem funcionalidades essenciais que deveriam estar prontas no MVP.

Fase	Capacidades sugeridas
Fase 2 — Integrações e produtividade clínica	Teleconsulta nativa, transcrição autorizada, prescrição certificada, integrações com prontuários/laboratórios, base de evidências e automações operacionais adicionais.
Fase 3 — Aquisição, relacionamento e receita	CRM, captação e qualificação de leads, funil comercial, campanhas, omnichannel, propostas, pagamentos, assinaturas e métricas de conversão.
Fase 4 — Inteligência e escala	BI avançado, análises populacionais, modelos preditivos validados, wearables, configurações por clínica, multiunidade, desempenho e governança em escala.

7.1 Critério para priorizar cada fase

1. Valor comprovado no piloto para médico, equipe e paciente.
2. Risco clínico, regulatório, de privacidade e de segurança controlado.
3. Dependências externas, custo recorrente e viabilidade técnica conhecidos.
4. Impacto mensurável em desfechos, adesão, tempo operacional ou crescimento.

7.2 Dependências para concluir o MVP

- Disponibilização dos protocolos, conteúdos, formulários e regras clínicas aprovadas pela clínica.
- Definição dos profissionais, pacientes e critérios do piloto controlado.
- Aprovação jurídica/LGPD, política de privacidade, consentimentos e responsabilidades operacionais.
- Escolha e contratação, quando aplicável, dos provedores de IA, mensagens, arquivos, teleconsulta ou prescrição.
- Participação dos responsáveis da clínica nas validações, testes e aceite de cada jornada crítica.

7.3 Fechamento de escopo

Compromisso de entrega

O protótipo define a experiência-alvo; o MVP entrega essa experiência funcionando para um piloto controlado. Praticamente tudo o que for aprovado no protótipo integra o MVP, junto com a infraestrutura e a governança necessárias para operar com segurança.

Qualquer exclusão relevante, substituição definitiva ou nova funcionalidade deverá ser registrada em decisão de escopo, com impacto em prazo, custo, risco e critério de aceite.